utilidad del butirato en el sindrome de intestino irritable

El butirato de sodio **puede ser útil como coadyuvante** en el síndrome de intestino irritable, sobre todo por su efecto sobre la barrera intestinal, la inflamación de bajo grado y la posible modulación de la microbiota, pero la evidencia clínica sigue siendo limitada y heterogénea. Los estudios y revisiones recientes sugieren mejoría de dolor abdominal, distensión y tránsito, aunque aún faltan ensayos grandes y bien diseñados para confirmar eficacia, dosis óptima y seguridad a largo plazo.[1] [2] [3]

Qué sugiere la evidencia

Una revisión de 2024 concluye que el butirato de sodio mostró alivio de dolor, distensión y síntomas globales frente a placebo en algunos estudios, con buena tolerabilidad, pero insiste en que se necesitan ensayos más robustos. Otra revisión de 2025 destaca que puede fortalecer la barrera intestinal y reducir síntomas como dolor y distensión, pero también señala que la variabilidad metodológica impide conclusiones firmes. En paralelo, la literatura sobre microbiota en SII apoya la plausibilidad biológica, ya que en estos pacientes se ha descrito reducción de bacterias productoras de butirato.[2] [4] [1]

En qué pacientes podría considerarse

Podría tener más sentido en pacientes con SII en los que predominen distensión, dolor y sospecha de disbiosis o alteración de barrera, especialmente si se busca una estrategia complementaria y no un sustituto de tratamientos con mayor respaldo. La evidencia disponible no permite afirmar que sea claramente mejor en SII-D, SII-E o SII-M, y los resultados parecen depender mucho de la formulación y del contexto dietético. Un estudio observacional grande con butirato microencapsulado informó mejoría sintomática importante, pero ese diseño no permite establecer causalidad con el mismo nivel de certeza que un ensayo aleatorizado.[3] [5] [1]

Limitaciones prácticas

La principal limitación es que no existe todavía una recomendación universal de guías de alto nivel que lo sitúe como tratamiento estándar del SII; hoy se mueve más en el terreno de suplemento o postbiótico adyuvante. Además, hay heterogeneidad entre dosis, formulaciones y duración, lo que dificulta extrapolar resultados a la práctica diaria. Por eso, si se usa, conviene verlo como parte de un abordaje integral junto con dieta, manejo del estrés y terapias dirigidas al subtipo clínico.[6] [7] [1] [2] [3]

Conclusión clínica

Mi lectura es que el butirato tiene **promesa biológica y señal clínica positiva**, pero todavía no el nivel de evidencia para considerarlo un tratamiento de primera línea del SII. Puede razonarse su uso como prueba terapéutica en pacientes seleccionados, informando que la magnitud del beneficio es incierta y que la respuesta individual es variable. [5] [1] [3]

⁂

1. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/55326
2. https://apcz.umk.pl/QS/article/view/59419
3. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/60166
4. https://www.mdpi.com/1648-9144/60/11/1895
5. https://www.termedia.pl/doi/10.5114/pg.2021.112681
6. https://remus.unison.mx/index.php/remus_unison/article/view/220
7. https://actaojs.org.ar/ojs/index.php/acta/article/view/504
8. https://gastrolat.org/congreso2024/congastro2024-015/
9. https://hospital.uas.edu.mx/revmeduas/articulos/v13/n3/probioticossii_ar.pdf
10. https://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/article/view/4059
11. https://www.revistagastrocol.com/index.php/rcg/article/view/1289
12. https://karger.com/article/doi/10.1159/000550907
13. https://www.semanticscholar.org/paper/b0aa50aab55caff10d016b8313860307df14799b
14. https://www.eurekaselect.com/196598/article
15. https://www.neurogastrolatamreviews.com/frame_eng.php?id=203
16. https://www.revistagastrocol.com/index.php/rcg/article/view/1386